Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	GASPAR SILVA ORELLANA.				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	12/12/20	Edad actual	4 años	9 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	USUALDO ROJAS 86, BIOEN.			Teléfono	955362315.		
Lengua materna	ESPAÑOL	Grado dominio	comprende ☑ habla ☐ lee ☐ escribe ☐				
Lengua de uso	ESPAÑOL	Grado dominio	comprende ☑ habla ☐ lee ☐ escribe ☐				
Escolaridad actual:	PRE-KINDER	Establecimiento	LICEO PARTICULAR MIXTO, B2.				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista:	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: PAULA ORELLANA.	Nombre:
Relación con el/la estudiante: MADRE.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista:	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: JAVIERA GARCÍA.	Nombre:
Rol/cargo: EDUCADORA DIFERENCIAL	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

INGRESO AL PIE.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☐ Sí (especificar)	
Pediatría: ASMA (TRATAMIENTO) X 4 MESES.	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida		
Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☑ cesárea (señalar motivo)		
Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO	Peso: 3.465	Talla: 51 cm.
Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:		
- PERITONITIS DURANTE EL EMBARAZO. - 10 DIAS CON ANTIBIOTICOS EN LA SEMANA 14 DE GESTACIÓN.		

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	Sí	~~No~~	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	Sí	~~No~~	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~Sí~~	No		Vacunas	~~Sí~~ / No

Observaciones:

- MACROCEFALIA FAMILIAR.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 3 MESES.	Se sienta sólo/a: 6 MESES.	Camina sin apoyo: 1 AÑO.
Primeras palabras: 1 AÑO.	Primeras frases: 3 AÑOS.	Se viste solo/a: SI.
Controla esfínter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓	Controla esfínter anal Diurno: ✓ Nocturno: ✓	

Observaciones:

GASPAR DEJA DE HABLAR AL AÑO Y LUEGO VUELVE HABLAR A LOS 3 AÑOS (SE COMUNICA CON PALABRAS SIMPLES).

En su actividad motora general se aprecia:

☐ normal ☒ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:

☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	~~Sí~~	No	Dominancia lateral	Sí	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	Sí	~~No~~	Escribe	Sí	~~No~~

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

Observaciones: —

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	~~Sí~~	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	~~Sí~~	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	~~No~~	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	~~Sí~~	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	~~No~~	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	~~Sí~~	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	~~No~~	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	~~No~~
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	~~Sí~~	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	~~Sí~~	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	~~No~~	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	~~No~~
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	~~Sí~~	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	~~No~~
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	~~No~~	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	~~No~~

Observaciones: EN OCASIONES ES TEMEROSO CON EL RUIDO.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma ☐ oral ☑ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	~~Sí~~	No	Emite/produce frases	~~Sí~~	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	~~Sí~~	No	Relata experiencias	Sí	~~No~~
Emite palabras/produce señas	~~Sí~~	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	~~No~~
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones simples	~~Sí~~	No
Identifica personas	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	~~No~~
Comprende conceptos abstractos	Sí	~~No~~	Sigue instrucciones grupales	Sí	~~No~~
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	~~No~~	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	~~Sí~~	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):					
Observaciones: EL ESTUDIANTE AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA ADQUISIÓN DEL LENGUAJE.					

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	~~Sí~~	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	~~No~~
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	~~No~~	Respeta normas sociales	Sí	~~No~~
Participa en actividades grupales	Sí	~~No~~	Respeta normas escolares	Sí	~~No~~
Opta por trabajo individual	~~Sí~~	No	Muestra sentido del humor	~~Sí~~	No
Presenta lenguaje ecolálico	~~Sí~~	No	Movimientos estereotipados	~~Sí~~	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	~~No~~	Pataletas frecuentes	~~Sí~~	No
Ante los siguientes estímulos su reacción es:					
Luces: ☐ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** ☐ natural ☐ desmesurada		**Personas extrañas:** ☐ natural ☐ desmesurada		
Observaciones: SE RELACIONA MEJOR CON LOS ADULTOS Y TAMBIÉN TIENE MAYOR AFINIDAD CON NIÑAS.					

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante					
Vacunas al día	~~Sí~~	No	Trastorno motor	Sí	~~No~~
Epilepsia	Sí	~~No~~	Problema bronco-respiratorio	~~Sí~~	No
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	Sí	~~No~~
Pérdida auditiva	Sí	~~No~~	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	Sí	~~No~~	Otro (especifique):		
El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): ASMA CON REMEDIOS CONTROLADOS.					
Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☑ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)					
Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad					
Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 10 horas.					
☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor	Duerme: ☑ solo ☐ acompañado (Especifique):				
Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*					
☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☑ risueño(a) ☐ triste ☑ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a) Otro:					
Observaciones: —					

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.				
Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. FELIPE SILVA.	PAPÁ	34	incompleta.	REPARTIDOR.
2. PAULA ORELLANA.	MAMÁ	35.	completa.	PROFESORA.
3. GASPAR SILVA.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

- AMBOS ABUELOS MATERNOS CON DIABETES.
- ABUELA MATERNA FALLA HEPATICA CRÓNICA.
- ABUELA PATERNA HIPERTENSIÓN.
- ABUELA PATERNA HIPOTIROIDISMO.

Observaciones:

—

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	2.	Asistió a jardín infantil	☑ Sí	No
Nº de colegios en que ha estudiado	3.	Modalidad de enseñanza Regular ☐ Especial ☐ Técnica ☐:		
Motivo de los cambios: DEBIDO A SU CONDICIÓN.		- NIDO DE GOLONDRINAS. - LAS VIOLETAS - FERROVIARIA.		
Ha repetido curso/s	Sí ☐	No ☑	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	PK "B"		**Dificultad de aprendizaje**	☑ Sí	No	**Dificultad para participar**	☑ Sí	No	**Conducta disruptiva**	☑ Sí	No
Asiste regularmente	☑ Sí	No	Asiste con agrado	☑ Sí	No	Apoyo familiar en tareas	☑ Sí	No	Amigos (as)	Sí	☑ No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

☑ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

☑ madre ☑ padre ☐ hermanos/as ☑ Otros familiares ☐ Otros profesionales ..... Abuelos .

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☒ Ambos ☐ Sólo fisico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

GASPAR LE GUSTA JUGAR DE MANERA BRUSCA, LO CALMA EL AGUA.

PRESENTA SENSIBILIDAD EN SU CABEZA (PELO).

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY